

NS 22222085157 / 742			
MARIO CHUTOKU NAKANICHI			
IDADE: 84a	PESO: 53	ALTURA: 168	PROFISSÃO: Engenheiro - Apos
SINTOMAS: <u>doença</u> ; cansaço; tem apnéias, caimbras			
QUEIXAS: <u>Polinéuropatia</u>			
MEDICAMENTOS: <u>Synthroid</u> / <u>Oscal D Cá</u> / <u>Antoprazol</u> / <u>Van naix</u> / <u>Spiriva</u>			
<u>Dorene</u> / <u>Milicamma</u> / <u>mg</u> / <u>Concor</u> / <u>Rosuvastatina</u> / <u>AAS</u>			
MÉDICO: <u>Dr. Mario Jorge</u>			
EXERCÍCIO FÍSICO: <u>não faz</u>			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: <u>7</u> ALMOÇO: <u>12</u> LANCHE: <u>-</u> JANTAR: <u>20h</u>			
HORA QUE DORME: <u>23h</u>		HORA QUE ACORDA: <u>6:30</u>	
COCHILO () SIM () NÃO		DORME ACOMPANHADO () SIM (X) NÃO () EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO			
FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: <u>1990 parou.</u>			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: <u>Nasal</u>		BANHEIRO: <u>1X</u>	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: <u>normal</u>		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: <u>asma</u>		MALLAMPATI: <u>IV</u>	
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: <u>DPOC</u>		IAH: <u>37lv</u> SPO2: <u>77%</u>	
CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA		MP Inquieta: <u>68.8lv</u>	
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: <u>não</u>		2 implantes stents.	
COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA <u>1stent.</u>		Pernas inquietas.	
(N) ORTOPÉDICA (X) NEUROLÓGICA () OUTROS			
<u>29/09</u> P= autom. p/ titular			
<u>23</u>			
<u>06/10/23</u> P= 6.0 cmH2O			
IAH= 2.7 elv			
m. de uso: 6h34'			
Relata que ainda <u>n</u> sentiu melhora			
da sonolência. <u>boa.</u>			
<u>23/10/23</u> P= 7.2 cmH2O P95%: 7.9 cmH2O. (Auto: 4 à 8 cmH2O)			
IAH= 6.0 cmH2O			
m de uso= 5h50'			
fuga= 29 l/min			
- fez COVID+ 3 dias UTI			
<u>30/10</u> P= 7.4 cmH2O			
IAH= 4.3 elv			
M. de uso: 6h			
Fuga 28.8 l/min.			
* comprou o CPAP.			
Relata melhora do			
quadro de covid. <u>boa.</u>			
<u>29/11/23</u> P= 7.4 cmH2O			
IAH= 7.1 elv			
m de uso= 5h37min			
fuga= 33 l/min.			
- Feito relatório 2 meses uso.			
<u>29/01</u> P= 7.4 cmH2O			
IAH= 6.0 elv			
fuga= 43 l/min			
m de uso= 5h15			
Dr. Mário Jorge manteve medica ^{ção}			
refre sonolência diurna / > dorene?			
dorme poucas horas. > pregabalina?			
regio atividade física -> {personal ?			
{fins ?			

de

25/03
24 P = 7.4 cmH₂O
IAH = 6.7 e/h
m. de uso: 4h 53'
fuga = 16.2 epm.

Ainda q sonolência devido
medicação

lua

23/05
24 P = 7.4 cmH₂O
IAH = 5.9 e/h
m. de uso: 4h 30'
fuga = 19.2 epm.

relata que ficou internado
p/ fazer o cateterismo.

lua

24/07
24 P = 7.4 cmH₂O
m. de uso: 5h 7'
IAH = 6.2 e/h
fuga = 10.2 epm.

Relata que está indo dormir
mais cedo, está movimentando
muito.

lua

25/09/24 P = 7.4 cmH₂O
IAH = 1.7 e/h
m. de uso: 5h 33'
fuga: 8.7 epm

Melhorou horas
de sono

Natasha

25/11
24 P = 7.4 cmH₂O
IAH = 1.8 e/h
m. de uso: 5h 9'
fuga = 11.4 epm.

Bem adapt. colocou 3 stents.

lua.

28/01/25 P = 7.4 cmH₂O
IAH = 2.0 e/h
m. de uso: 5h 40'
fuga: 9.0 epm

Bem adaptada
Relata indicação CPAP

Natasha

25/03/25 P = 7.4 cmH₂O
IAH = 1.7 e/h
m. de uso: 5h 30'
fuga: 22.2 epm

* Colocou marcação
Traco máscara p/ Pico.

Natasha

23/05/25 P = 7.4 cmH₂O
IAH = 1.3 e/h
m. de uso: 6h 2'
fuga: 32.8 epm

Ajuste máscara mirage fx

Natasha

23/07
25 P = 7.4 cmH₂O
IAH = 1.9
m. de uso: 6hr
fuga = 11.9

trocou o tubo

lua.

CLÍNICA

DR. ALBERTO REMESAR

PSIQUIATRIA

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

CRM-SP 69730

DR. ELITÂNIA MARINHO PONTES

CRM-SP 62858

TTS = 7h 2x

NOME: Mario Chutoku Nakanichi

EXAME nº: 5385

SOLICITADO POR: Dr. Mário Silva Jorge

DATA: 18/05/2023

IDADE: 84 anos

Comentários:

Exame iniciado às 23h03min e concluído às 06h04min. A latência para o sono foi de 6 minutos e a latência para o estágio REM, de 32 minutos. O tempo total de sono foi de 253 minutos (04h13min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 61,9%. A distribuição do sono mostrou 19% de estágio 1, 48,6% de estágio 2, 14,4% de estágio 3 e 18% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 150 minutos em vigília, ocorreram 74 microdespertares (índice: 17,5/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 68,8/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 37/hora, sendo 18,3 apneia/hora e 18,7 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 41,3/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 96%, sendo a saturação média de 93% e a mínima de 77%.

(*) TTS = Tempo Total de Sono

TTR = Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (37/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (41,3/hora), episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina, principalmente durante o decúbito dorsal, arritmia cardíaca e despertares. As frequências cardíacas foram: mínima: 50; máxima: 71 bpm.

O ronco foi contínuo e baixo.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 6 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava encurtada (32 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 61,9%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 17,5/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (19%; normal: 8-10%) e 3 (14,4%; normal: 10-12%), e a redução do estágio REM (18%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 2 (48,6%; normal: 45-55%) permaneceu nos limites da normalidade.

Aumento do índice de movimentos periódicos de membros (68,8/hora; índice normal até 15/hora).

Escala de Sonolência de Epworth: 14 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico
CRM 69730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730

Mário Silva Jorge

Neurologia – CRM27123
Membro Efetivo da Academia de Neurologia
Membro Titular da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica
Member's of International Headache Society
Doutor em Neurologia Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP)
Médico do Ambulatório de Reabilitação Cognitiva da Disciplina de Neurologia da FMUSP

São Jose dos Campos 04/05/2023

a

Aua Claudes

Eucarello p/ esse avaliar o paciente

Mário CHUTOKU, com quadro de SAOS

H us de CPAP.

realizar exame de PSG, esse exame.

Akuciofalete

Dr. Mário Silva Jorge

CRM 27.123

Cons.: UNEP – DEPARTAMENTO DE NEUROLOGIA
Rua Cel. José Domingos de Vasconcelos, 400 – V. Adyanna – São José dos Campos
Tel.: (0xx12) 3921-2071 / Telefax: (0xx12) 3921-4177
Eletroencefalograma – Mapeamento Cerebral